Anamnesefragen DR. SÜMEYRA FIRAT
Aufklärung
Patientinvorstellung

ACS-Florian Willms

Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Monentan haben Sie Brustschmerzen?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Nur in einem bestimmten Bereich oder im gesamten Brustkorb?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Haben Sie Luftnot oder ein Engegefühl?
Besteht ein Zusammenhang zwischen Brustschmerzen und der Atemnot?
Leiden Sie manchmal an Herzrasen oder -klopfen?

Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach Stress oder *Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?*
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Wie lange dauert eine Attacke?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Wie oft, Wie lange haben sie damals gedauert? Sind Sie bei Belastung oder auch in Ruhe aufgetreten?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurde Ihnen Untersuchung durchgeführt?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Ist Ihnen Schwindel? Welche Art von Schwindel? Ist es so, wie im Karussell(Drehschwindel) wie Bootfahren(Schwankschwindel)
Haben Sie schon Bewustsein verloren?
Haben Sie Todesagst?
Fühlen Sie sich Müde?
Haben Sie Klatschweiß?
Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?

Haben Sie Husten und Fiber?
Haben Sie Probleme beim Treppensteigen? Wie viele Etagen können Sie ohne Probleme gehen?
Sind Ihre Beine angeschwollen?
Mussen Sie nachts öfter zum Wasserlassen?
Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht zugenommen?
Können sie flach liegen oder brachen Sie mehrere Kissen beim Schlafen?

Haben Sie geschwollene, gerötete oder warme Beine bemerkt? Oder Wadenschmerzen?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

Vorstellung:
Guten Tag Herr Oberarzt, "Sümeyra" ist mein Name.
Heute haben wir einen neuen Patientinen aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patientinen vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.

🩺 Fallvorstellung (Indikativ-Version)

Nun möchte ich gerne den Fall meines Patienten berichten.
Es geht um **Herrn Florian Willms**. Er ist ein 38-jähriger Patient, geboren am 02.02.1982. Er ist 1,87 m groß und wiegt 94,5 kg.
Herr Willms kam zu uns wegen heute Morgen aufgetretener retrosternaler Thoraxschmerzen in Ruhe, mit Ausstrahlung in den linken Arm und in den Hals.
Der Patient beschreibt die Schmerzen zunächst als stechend, brennend, ziehend und dumpf, später eher als drückend. Die Schmerzintensität lag zu Beginn bei 5–6 von 10, aktuell bei 3–4 von 10. Die Symptome besserten sich spontan.
In der Vergangenheit berichtete er über ähnliche Beschwerden in den letzten zwölf Monaten, insgesamt 2–3 Episoden, jeweils bei Belastung, insbesondere beim Treppensteigen. Diese Attacken dauerten etwa 30 Minuten und verschwanden in Ruhe.
Zusätzlich klagte er heute über Kaltschweißigkeit, Übelkeit, Schwindel, Schwarzwerden vor Augen, Fatigue, Palpitationen und Blässe.
An Vorerkrankungen bestehen ein chronischer Husten mit Auswurf aufgrund des Nikotinkonsums sowie eine durchgemachte Zytomegalievirus-Infektion im Alter von 25 Jahren mit Lymphknotenschwellungen. Er berichtet über Inappetenz, eine Gewichtszunahme von 3 kg in den letzten drei Jahren, Schlafstörungen und Angstzustände.
Bekannte Operationen sind eine Unterschenkeloperation links nach einem Autounfall, komplikationslos.

Der Impfstatus ist vollständig.
Medikamentös nimmt er ACC in unklarer Dosierung.
Eine Allergie ist nicht bekannt.
Zu den Noxen:
Der Patient raucht seit dem 18. Lebensjahr, aktuell etwa 20 Zigaretten pro Tag in den letzten 3 Jahren. Zuvor rauchte er etwa 10 Zigaretten pro Tag. Er trinkt gelegentlich am Wochenende 1–2 Flaschen Bier oder 2–3 Gläser Wein.
Drogenkonsum wird verneint.
In der Familienanamnese berichtet er:
Der Vater verstarb im Alter von 50–55 Jahren an einem Myokardinfarkt, bekannt war auch eine arterielle Hypertonie und Glaukom.
Die Mutter leidet an einer rheumatoiden Arthritis, behandelt mit Medikamenten, zusätzlich bestehen Bandscheibenprobleme und eine Kniegelenkentzündung.
Die Schwester ist adipös, leidet an Depressionen und Varizen.
Seine 11-jährige Tochter hat ein Hühnerauge am Fuß.
Der Patient äußert Sorgen über die Varizen seiner Schwester sowie über das Hühnerauge seiner Tochter und bittet um ärztlichen Rat.
Sozialanamnese:
Herr Willms ist Speditionskaufmann und beschreibt seine Arbeit als stressig. Er ist verheiratet, lebt jedoch seit 3 Jahren getrennt und ist alleinerziehend mit seiner Tochter. Die Ehefrau lebt mit einem anderen Partner in Thailand. Er berichtet über familiäre Konflikte mit seiner Tochter in der Pubertät sowie über Streitigkeiten zwischen Tochter und aktueller Freundin.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein **akutes Koronarsyndrom (ACS)** hin.
Die plötzlich aufgetretenen retrosternalen, stechend-dumpf-drückenden Thoraxschmerzen in Ruhe, die Progredienz seit mehreren Monaten sowie die Begleitsymptome (Palpitationen, Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Schwindel, Schwarzwerden vor Augen, Fatigue, Blässe) sprechen für diese Verdachtsdiagnose.
Differentialdiagnostisch kommen eine **Lungenembolie (LAE)**, ein **Pneumothorax**,(söyleme danisc de söyleme denilmiş) eine **Aortendissektion, eine Perikarditis(hiçbir yerde geçmiyor)** sowie ein **gastroösophagealer Reflux (GERD)** in Betracht.
Zur weiteren Abklärung führe ich zunächst die **körperliche Untersuchung** durch und überwache die **vitalen Parameter**.

Als routinemäßige und wichtige Maßnahme sollte ein **EKG** geschrieben werden.
Im Labor würde ich folgende Parameter bestimmen lassen:

- großes Blutbild
- Blutzucker,
- BSG, CRP, (Blutsenkungsgeschwindigkeit-Sedimantasyon),(C-Reaktives Protein)
- D-Dimer,(Der D-Dimer ist ein Abbauprodukt von Fibrin und wird vor allem beim Verdacht auf eine tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie bestimmt.“)
- kardiale Marker: Troponin I/T, CK-MB (Creatin-Kinase-Muskel-Brain- **Kalbe özgü kreatin kinaz izoenzimi:** Kalp kası hasarında yükselir- CK-MB ist herzspezifisch und erhöht sich bei Myokardschädigung.),
- Elektrolyte (Na, K, Ca),
- Gerinnungsdiagnostik (INR, PTT, Quick, Fibrinogen- Beurteilt das Gleichgewicht zwischen Blutgerinnung und Blutungsneigung),
- TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon)- obstipation varsa iste
- Lipid profil

INR (International Normalized Ratio)

- **„Die INR dient zur standardisierten Beurteilung der Blutgerinnung und wird vor allem unter Marcumar- oder Vitamin-K-Antagonisten-Therapie bestimmt.“**
  👉 (Kanamanın pıhtılaşmaya göre standardize değerlendirilmesi, özellikle oral antikoagülan takibinde.)

PTT (Partielle Thromboplastinzeit)

- **„Die PTT misst die Aktivität des intrinsischen und gemeinsamen Gerinnungsweges.“**
  👉 (İçsel ve ortak pıhtılaşma yolunu değerlendirir.)

Quick-Wert

- **„Der Quick-Wert gibt Auskunft über den extrinsischen Gerinnungsweg und wird ebenfalls zur Kontrolle einer Antikoagulation herangezogen.“**
  👉 (Dışsal yolu değerlendirir, antikoagülasyon takibinde kullanılır.)

Fibrinogen

- **„Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein und Substrat der Gerinnung, erniedrigt bei Verbrauchskoagulopathien und erhöht bei Entzündungen.“**
  👉 (Pıhtılaşma için gerekli, DIC’te azalır, inflamasyonda artar.)

Apparative Diagnostik:

- Echokardiografie,
- Röntgen-Thorax, (AORT DİSSEKTİONU DIŞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ GGF. CT-ANGİOGRAPHİE THERAPİE PCI)

- bei Bedarf Koronarangiografie.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:

- stationäre Aufnahme mit Monitoring,
- Therapie nach dem **MONA-BH-Schema**:
  - Morphin (3 mg i.v., ggf. wiederholt),- Morphin 3 mg intravenös, bei Bedarf kann die Gabe wiederholt werden.
  - Sauerstoffgabe (bei $SpO_2 < 90\%$),-Sauerstoffgabe bei einer Sättigung unter 90 Prozent.
  - Nitroglycerin (sofern keine Hypotonie vorliegt),- Nitroglycerin sublingual oder als Spray, nicht bei Hypotonie
  - ASS 300 mg i.v.,- Aspirin 300 mg intravenös als Bolus.
  - Heparin 5000 IE i.v.,- Heparin 5000 Internationale Einheiten intravenös als Bolus.
  - Clopidogrel 600 mg p.o.

- (Zusätzlich verordne ich) bei Bedarf **Antiemetika** sowie **Sedativa**.
- Weiterhin (habe ich ein **kardiologisches Konsil** veranlasst. Je nach Befund erwägen wir eine) Koronarangiografie mit ggf. perkutaner Koronarintervention (PCI) oder **Bypass-Operation**
- Es soll eine konsequente **Nikotinkarenz und Alkoholkarenz** eingehalten werden. Parallel ist eine **Patientenschulung** sowie eine **Stressbewältigungstherapie** vorgesehen.

🔹 Koronerangiografie (Koroner anjiyografi)

- **Tanısal (diagnostisch)** bir yöntemdir.
- Kateterle kalbe gidilir, koroner damarlara kontrast madde verilir.
- Amaç: Damarların darlığını, tıkanıklığını **görmek**.
- Yani **sadece teşhis**.

👉 Örnek: „Wir machen eine Koronarangiografie, um zu sehen, ob eine Engstelle im Herzkranzgefäß besteht.“

🔹 Perkutane Koronarintervention (PCI)

- **Tedavi edici (therapeutisch)** bir işlemdir.
- Koroner anjiyografi sırasında darlık saptanırsa, aynı seansta balon (PTCA) veya stent yerleştirilir.
- Yani **tıkanıklığı açmak / damarı tedavi etmek**.

👉 Örnek: „Falls eine hochgradige Stenose gefunden wird, führen wir eine PCI mit Stentimplantation durch.“

📌 **Özet:**

- **Koroner anjiyografi → teşhis**
- **PCI → tedavi** (anjiyo sırasında yapılabilir)

Zur Sekundärprophylaxe (Reinfarktprophylaxe) wären Statine, Betablocker, ACE-Hemmer sowie ASS und/oder Clopidogrel indiziert.
Bu ilaçlar **Sekundärprophylaxe (Reinfarktprophylaxe)** içindir.

👉 Yani hasta **akut olay sonrası stabil hale geldiğinde** başlanır ve **taburcu olduktan sonra uzun süreli (çoğu zaman ömür boyu)** devam edilir.
İlk müdahalede (z. B. STEMI/NSTEMI → PCI sonrası) zaten kısmen başlanır, sonra evde devam edilir.

🔹 2. Hangi ilaçlar ve neden?

- **Statin**
  - Amaç: LDL düşürmek, Plaque-Stabilisierung, Entzündungshemmung
  - Her ACS hastasında, LDL normal olsa bile başlanır.
- **Betablocker**
  - Amaç: Herzfrequenz und Blutdruck senken, O2-Verbrauch azaltmak, Reinfarkt riskini düşürmek
  - Kontrendikasyon yoksa (ör. AV-Block, schwere Asthma) → başlanır.
- **ACE-Hemmer**
  - Amaç: Remodeling önlemek, Blutdruck kontrolü, kardioprotektiv
  - Özellikle: Linksherzinsuffizienz, Diabetes, Hypertonie varsa kesin başlanır.
- **ASS und/oder Clopidogrel (duale Plättchenhemmung)**
  - Amaç: Stent-Trombose ve Reinfarkt önlemek
  - PCI/Stent sonrası → genelde **ASS lebenslang + Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel für 6–12 Monate**
  - Eğer Stent yoksa → ASS çoğunlukla tek başına, bazen ek antiplättchenhemmmung.

🔹 3. Hangi kombinasyon seçilir?

- **Standard bei ACS + PCI:**
  - ASS (lebenslang)
    - Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel (für 6–12 Monate)
    - Statin
    - Betablocker (falls keine KI) (KI-Kontraendikasyon)

        - ACE-Hemmer (falls keine KI)
- **Seçim kriterleri:**
    - Komorbiditeler (ör. Astım varsa betabloker dikkat)
    - Kontrendikasyonlar (ör. böbrek fonksiyonuna göre ACE-Hemmer)
    - Kanama riski (Dualplättchenhemmung süresine etki eder)
    - Lipidprofil (ama statin zaten çoğu kez verilir)

📌 Özet:
Evet, bu ilaçlar **hastanın eve gönderilirken başlanacak ve uzun vadede devam edilecek standart tedavileridir.**
Hangi ilacın verileceği **risk faktörlerine, eşlik eden hastalıklara ve kontrendikasyonlara** göre belirlenir.
👉 İstersen ben sana **ACS sonrası taburculuk için standart „Medikationsplan“ (Tablo şeklinde: Medikament – Ziel – Dauer)** hazırlayayım mı?

🩺 **ACS – Sekundärprophylaxe (nach Entlassung)**

Medikament	Zweck / Wirkung	Dauer / Bemerkung
ASS (Aspirin)	Thrombozytenaggregationshemmer → verhindert Reinfarkt, Stentthrombose	Lebenslang (sofern keine KI)
Clopidogrel / Ticagrelor / Prasugrel	Zweiter Thrombozytenhemmer (DAPT)	Meist 6–12 Monate nach PCI, dann evtl. nur ASS
Statin (z. B. Atorvastatin, Rosuvastatin)	Senkt LDL, stabilisiert Plaques, antiinflammatorisch	Lebenslang, unabhängig vom LDL-Wert
Betablocker (z. B. Metoprolol, Bisoprolol)	Senkt Herzfrequenz & Blutdruck, reduziert O_2-Verbrauch, senkt Reinfarktrisiko	Dauertherapie, wenn keine Kontraindikation (z. B. AV-Block, Asthma)
ACE-Hemmer (z. B. Ramipril, Enalapril)	Verhindert Remodeling, kardioprotektiv, Blutdruckkontrolle	Lebenslang, v. a. bei Hypertonie, Diabetes, Herzinsuffizienz
Alternativ: AT1-Blocker (z. B. Valsartan)	Falls ACE-Hemmer nicht vertragen wird (z. B. Husten)	Lebenslang

Medikament	Zweck / Wirkung	Dauer / Bemerkung
Evtl. Aldosteronantagonist (Eplerenon, Spironolacton)	Bei EF < 40% oder Herzinsuffizienz	Langfristig, abhängig von EF und Symptomen

📌 Kurz zusammengefasst:

- **Immer:** ASS + Statin
- **Nach PCI:** zusätzlich Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel (6–12 Mon.)
- **Falls möglich:** Betablocker + ACE-Hemmer
- **Bei spezieller Indikation:** Aldosteronantagonist

Dies sind die bisherigen Maßnahmen. Den Fall möchte ich nun gerne mit Ihnen besprechen.

Reaktionen:
Patienten-Asistanarztin

1) Was habe ich? Ist es gefährlich?
   Başlangıçta: Sie haben Brustschmerzen, das kann manchmal harmlos sein, aber auch vom Herzen kommen. Deshalb nehmen wir es sehr ernst und müssen Sie sofort untersuchen.
   Sonda: Es tut mir leid, dass Sie sich so schlecht fühlen. Ein Myokardinfarkt tritt auf, wenn eine Blockade in den Blutgefäßen, die das Herz mit Blut versorgen, dazu führt, dass das Herzgewebe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Dies kann zu Schmerzen oder einem Druckgefühl in der Brust führen, die oft bis in den linken Arm ausstrahlen können.
2) Was sind chronische Krankheiten?
   Chronische Krankheiten sind Erkrankungen, die lange bestehen bleiben, zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes oder chronische Bronchitis.
3) Ich habe keinen Hausarzt.
   In Ordnung, das ist kein Problem. Wir kümmern uns jetzt hier um Sie. Später wäre es gut, einen festen Hausarzt zu haben.
4) Meine Schwester ist übergewichtig, BMI 35. Wie kann man sie behandeln?
   Für Ihre Schwester ist es wichtig, einen gesunden Lebensstil zu führen, um ihr Übergewicht zu reduzieren und mögliche damit verbundene

Gesundheitsprobleme zu minimieren. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität. Ihre Schwester sollte zu einem Hausarzt oder Ernährungsmediziner gehen.

5) Meine Ex-Frau hat eine Wunde am Bein. Könnten Sie auch mein Bein untersuchen?
Natürlich! Ich freue mich, Ihnen so weit wie möglich zu helfen, wir werden die körperliche Untersuchung nach Abschluss dieses Gesprächs durchführen

6) Warum soll ich hierbleiben? Kann ich gehen, weil ich meine Tochter von der Schule abholen muss?
Sie sollten hierbleiben, weil wir einen Herzinfarkt ausschließen müssen. Das ist gefährlich, wenn man es nicht behandelt. Ihre Tochter können wir gemeinsam mit dem Sozialdienst oder Familie versorgen, bis Sie stabil sind.

7) Soll ich im Krankenhaus bleiben?
Ja, wir müssen Sie überwachen, EKG und Blutuntersuchungen machen, um sicherzugehen, dass es kein Herzinfarkt ist.

8) Habe ich Risikofaktoren für einen Herzinfarkt? Wenn ja, welche?
Ja: Rauchen, Stress, Übergewicht und die Familiengeschichte – Ihr Vater hatte auch einen Herzinfarkt.

9) Was ist mit mir passiert, wieso sind diese Symptome aufgetreten?
Wahrscheinlich wegen einer Durchblutungsstörung am Herzen. Deshalb müssen wir das sofort prüfen.

10) Was werden Sie mit mir machen?
Zuerst ein EKG, Blutuntersuchung, dann Herzultraschall. Falls nötig, überweisen wir sofort zum Kardiologen.

11) Was ist EKG, ist es schmerzhaft? Werden Sie mir mit Metallplättchen in den Körper stechen?
Ein EKG ist eine Untersuchung, bei der wir die elektrische Aktivität Ihres Herzens messen. Wir kleben kleine Elektroden auf die Haut, das tut nicht weh und es wird nichts in den Körper gestochen. Wir zeichnen nur den Herzrhythmus auf.

12) Was ist MI?
MI bedeutet Myokardinfarkt – das ist der medizinische Begriff für Herzinfarkt

13) Muss ich gespritzt werden? Haben Sie kleine Nadeln?
keine Sorge! wir haben kleine nadeln, aber ja, wir müssen Labortests durchführen.

14) Müssen Sie Mittel ins Blut spritzen? Kontrastmittel?
Nur wenn wir bestimmte Untersuchungen wie ein Herzkatheter machen. Für EKG und normale Bluttests brauchen wir kein Kontrastmittel.

15) Komme ich in die Röhre?
Nein, nicht sofort. Nur wenn wir später ein CT oder MRT brauchen.

16) Machen Sie für mich eine Magenspiegelung? Soll ich in ein Rohr sitzen?
Nein, jetzt geht es um Ihr Herz, nicht um den Magen. Eine Magenspiegelung ist hier nicht nötig.

17) Warum machen Sie einen Herzultraschall? Bin ich schwanger?
(lächelt freundlich) Nein, Ultraschall ist nicht nur für Schwangerschaften. Wir können damit auch Ihr Herz von außen genau untersuchen.

18) Zuerst wollte ich auf jeden Fall sofort ein EKG durchführen.
Genau, das ist der erste Schritt – und den machen wir sofort

19) **Ich habe Probleme mit meiner Tochter, da sie sich in der Pubertät befindet. Meine Tochter und meine Freundin streiten immer. Sie kann nicht in die Wohnung kommen:**
Ich verstehe, was Sie sagen, und ich weiß, dass es schwierig sein kann, wenn es Probleme zwischen Familienmitgliedern gibt. Ich würde eine Familientherapie vorschlagen, um Lösungen für das Problem zu finden. Das ist natürlich ein persönlicher Rat und kein medizinischer. Das ist eine ganz normale Phase im Leben. Sie müssen geduldig sein

20) **Meine Tochter ist 11 und hat einen Freund.**
Es ist wichtig, ein offenes Gespräch mit Ihrer Tochter darüber zu führen und ihr Verhalten zu beobachten.

21) **Warum fragen Sie nach Drogen?**
Diese Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich.
Drogen haben viele Nebenwirkungen. Deshalb muss ich fragen.
Wenn Sie ja sagen, dann würden wir die Dosis Ihrer Medikamente anpassen.
Wenn Sie eine Entzugstherapie benötigen, dann kann ich die anbieten.
Machen Sie sich keine Sorgen, ich gebe Ihre Angaben nicht weiter. Das ist unsere Regel.

22) **Was ist Glaukom-Grüner Star?**
Es ist eine Augenkrankheit und passiert öfter bei älteren Menschen. Es geht um einen erhöhten Augeninnendruck.

23) **Ist grüner Star erblich? Kann meine Tochter daran leiden?**
Glaukom kann familiär gehäuft auftreten. Das heißt, ein gewisses Risiko besteht auch für Ihre Tochter. Ich würde empfehlen, dass sie einen Augenarzt besucht, der Ihr besser weiterhelfen kann als ich.
Leider bin ich keinen Augenärztin Herr Willms und dieses Thema fällt nicht in meinem Fachgebiet (bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor). Ich würde empfehlen, dass sie einen Augenarzt besucht, der Ihr besser weiterhelfen kann als ich.

24) **Meine Schwester hat blaue Streifen unter die Haut? Was ist das? Sind Krampfadern behandelbar? Sollte meine Schwester operiert werden?**
Das können Dehnungsstreifen oder auch Venenprobleme sein. Ein Arzt muss das genau anschauen.
Ja, Krampfadern sind behandelbar. Manchmal reicht Kompressionstherapie, manchmal ist eine OP nötig. Das entscheidet der Gefäßspezialist. Ich würde empfehlen, dass sie **einen Gefäßchirurg** besucht, der Ihnen besser weiterhelfen kann als ich.
(Die blauen Streifen unter der Haut könnten Dehnungsstreifen(çatlaklar) sein, die durch schnelles Wachstum(hızlı büyüme) oder Gewichtszunahme verursacht werden. In der Regel sind sie nicht gesundheitsschädlich(sağlık açısından zararlı) und verblassen(solmak) mit der Zeit.)
Wenn es sich um Krampfadern handelt, können diese behandelt werden, wenn sie Beschwerden verursachen oder kosmetisch störend sind. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten wie Kompressionsstrümpfe, Sklerotherapie und Operation. Ob Ihre Schwester operiert werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Schweregrad der Krampfadern und dem Ausmaß der Beschwerden. Es ist wichtig, dass sie sich von einem Facharzt für Gefäßchirurgie untersuchen lässt, um eine individuelle Empfehlung zu erhalten.

25) **Wo muss sie gehen?**
Zum Gefäßchirurg

26) **Meine Tochter hat Hühnerauge, was soll ich machen? Zu welchem Arzt soll sie gehen? Sollte ich sie zum Augenarzt bringen?**
Nein, das ist eine Hautveränderung am Fuß. Ein Hühneraugen(es) wird durch Druck oder Reibung verursacht. (Druck oder Reibung kann ein Hühnerauge verursachen) Sie sollten mit ihr zum Hautarzt oder Orthopäden gehen. Ein Augenarzt ist dafür nicht **zuständig.**
„Sie sollten mit ihr den Hautarzt oder Orthopäden aufsuchen.“
👉 Daha **resmî / tıbbi**: “Onunla birlikte bir dermatoloğa veya ortopede başvurmalısınız.”

27) **Hühnerauge: Wie kann man es vermeiden?**
Achten Sie auf bequeme, passende Schuhe und vermeiden Sie Druck am Fuß. Ich empfehle Ihnen trotzdem, mit Ihrer Tochter einen Hautarzt oder Orthopäden aufzusuchen. Dort kann die Ursache genau abgeklärt und eine passende Behandlung begonnen werden.

28) **Sind Herzinfarkte erblich?**

Ja, Herzinfarkte können erblich bedingt sein. Wenn Ihre Mutter oder Ihr Vater an einer Herzerkrankung leiden, ist Ihr Risiko für eine Herzerkrankung höher. Ein gesunder Lebensstil und regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind wichtig, um das Risiko zu **verringern.**

29) **Ich möchte jetzt rauchen.**
Aber ich möchte das Aufnahmegespräch zuerst **abschließen**, damit alles vollständig ist. Danach können Sie gerne eine Raucherpause machen. Allerdings ist Ihnen sicherlich bewusst, dass Rauchen sehr schädlich ist. Es ist wichtig, dass Sie jetzt mit dem Rauchen aufhören. Rauchen erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich. Gerade in Verbindung mit einem akuten Koronarsyndrom steigt die Gefahr für einen erneuten Anfall erheblich. Deshalb empfehle ich Ihnen dringend, sofort damit aufzuhören."

30) **hasta çok soru sorduğunda;**
Es tut mir leid, wenn ich nicht auf alle Ihre Fragen geantwortet habe. Ich versuche, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, aber manchmal ist es aufgrund von Zeitbeschränkungen schwierig, alle Fragen zu beantworten. Wenn ich mit der Abfrage der wichtigsten Informationen fertig bin, werde ich versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten, da es jetzt wichtig ist, sich auf die wichtigen Informationen zu konzentrieren, damit Sie so schnell wie möglich die richtige Behandlung erhalten. In Ihrem Fall handelt es sich um das Herz, und das kann lebensbedrohlich sein. Deshalb möchte ich jetzt die wichtigsten Informationen sammeln, damit ich so schnell wie möglich mit der Behandlung beginnen kann.

Oberarzt-Asistanarztin

1) Warum fragen wir den Patienten nach seinem Gewicht und seiner Größe?
Um den Body-Mass-Index (BMI) zu berechnen und die richtige Dosierung von Medikamenten festzulegen.

2) Was bedeutet „Geburtsname"?
Das ist der Familienname einer Person vor der Heirat. Bei Frauen oft der Mädchenname.

3) Welche Arten von Schmerzen hat der Patient beschrieben?
Er berichtete anfangs über stechende, brennende, ziehende Schmerzen, später eher dumpf und drückend.

4) Wo befand sich der Patient, als er die Beschwerden bekommen hat?
Er war im Büro, bei der Arbeit.

5) Was bedeutet es, dass er die Beschwerden auch in Ruhe hat?
Das spricht dafür, dass nicht nur Belastungsangina, sondern auch eine instabile Angina pectoris oder sogar ein akutes Koronarsyndrom vorliegen könnte.
6) Ist es das erste Mal, dass der Patient solche Symptome hat?
Nein, er hatte ähnliche Beschwerden bereits 2–3 Mal im letzten Jahr, aber damals nur bei Belastung.
7) Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten, wie „aus heiterem Himmel“? Wissen Sie, was „aus heiterem Himmel“ bedeutet?
Ja, sie sind plötzlich aufgetreten, in Ruhe. „Aus heiterem Himmel“ bedeutet völlig unerwartet, ohne Vorwarnung.
8) Wie hat der Patient den Kaltschweiß beschrieben? Und warum kommt es zu Kaltschweißigkeit? Wo ist die Haut kalt? Was ist die Wichtigkeit?
Er hat starkes Schwitzen bei kalter Haut beschrieben. Kaltschweißigkeit entsteht durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems und ist ein wichtiges vegetatives Begleitsymptom, z.B. beim Herzinfarkt.
9) War er wegen dieser Beschwerden jemals beim Arzt? Und was hat der Arzt ihm damals gesagt?
Nein, bisher war er deswegen nicht beim Arzt.
10) Hat der Patient Husten? Wenn ja, ist er trocken oder mit Auswurf?
Ja, er hat chronischen Husten mit Auswurf, aufgrund des Rauchens.
11) Warum nimmt der Patient ACC? Was ist das für ein Medikament?
Er nimmt ACC als schleimlösendes Medikament, allerdings in unklarer Dosierung.
12) Woran leiden seine Mutter und seine Schwester?
Die Mutter hat eine rheumatoide Arthritis, die medikamentös behandelt wird. Die Schwester leidet an Adipositas, Depressionen und Varizen.
13) Und was bedeutet „Pubertät“?
Pubertät ist die Entwicklungsphase des Jugendlichen, in der körperliche und hormonelle Veränderungen stattfinden und die Geschlechtsreife (cinsel olgunluk) erreicht wird.
14) Was macht ein Speditionskaufmann?
Er ist für die Planung und Organisation des Gütertransports(yük taşımacılığı) verantwortlich.
15) Warum ist der Patient gestresst?
Wegen seines Berufs (Transport, oft stressig) und auch durch private Belastungen: Scheidung, alleinerziehend, Konflikte mit Tochter und Freundin.

16) Was ist ein Buchhalter?
Ein Buchhalter führt die Buchhaltung eines Unternehmens, also die systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle.

17) Und wie nennen wir den Mann, der ein Buch verkauft?
Das ist ein Buchhändler.

18) Was ist der Unterschied zwischen Buchhaltung und Buchhandlung?
Buchhaltung = Abteilung für Finanzen und Rechnungswesen.
Buchhandlung = Geschäft, in dem man Bücher kaufen kann.

19) Wie unterteilen wir das akute Koronarsyndrom (ACS)?
In STEMI, NSTEMI und instabile Angina pectoris.

20) Welche Risikofaktoren hat der Patient für ACS?
Nikotinabusus, familiäre Belastung (Vater MI mit 50), *Übergewicht,* Stress, Bewegungsmangel.

21) Was sind die Diagnosekriterien für Myokardinfarkt?
Typische Symptome (Brustschmerz), typische EKG-Veränderungen und Anstieg kardialer Marker (Troponin).

22) Woraus besteht die Angina pectoris?
Typische retrosternale Schmerzen, ausstrahlend in Arm/Hals, Druck/Engegefühl, oft mit vegetativen Symptomen wie Kaltschweißigkeit, Übelkeit.

23) Welche Komplikationen kann ein Myokardinfarkt haben?
Herzrhythmusstörungen, z. B. Vorhofflimmern (VHF) oder Kammerflimmern.

24) Warum denken wir an eine Perikarditis? Was sind typische Symptome?
Atemabhängige thorakale Schmerzen, oft mit Perikardreiben, bessern sich beim Aufsitzen.

25) Warum auch an LAE denken?
Weil Lungenembolie (LE) ebenfalls akute Thoraxschmerzen und Dyspnoe verursacht. (Nicht zu verwechseln mit Lupus erythematodes, der gleiche Kürzel hat.)

26) Was sind die vitalen Parameter?
Herzfrequenz, Atemfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur.

27) Wer muss sofort informiert werden bei STEMI-Befund?
Der Kardiologe.

28) Kann man bei ACS immer Nitrospray geben?
Nein. Bei Kaltschweißigkeit oder Hypotonie ist es gefährlich. Bei STEMI keine routinemäßige Anwendung empfohlen – in der Akutphase besser Opioide. Bei NSTEMI kann Nitro zur Anginakontrolle erwogen(dikkate alınabilir) werden.

29) Geben Sie dem Patienten Aspirin, wenn er bereits vor der Notaufnahme ASS eingenommen hat?
Nein, nur bei ASS-naiven(kullanmayan) Patienten.

30) Auf welcher Station würden Sie diesen Patienten aufnehmen?
Auf der Intensivstation (ITS).

31) Welche Therapie erfolgt sofort in der Notaufnahme?
EKG schreiben, den Kardiologen rufen, Basistherapie (z. B. ASS, Heparin), Monitoring.

32) Der Patient sagt, dass ich gehen sollte, um mich um meine Tochter zu kümmern: Was machen Sie?
Ich rufe den Sozialdienst an.

- Verlegungsbrief: KH zu Reha
- Kostenübernahmeantrag: KH zu Krankenkasse

2. ACS s.18

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Ich habe schon meine Versicherungskarte gegeben.
  - Es ist wichtig, die Daten zu bestätigen. Damit wir Sie nicht mit anderen Patienten verwechseln.
- Florian Willms
- 42 J.
- *02.02.1982
- 94,5 kg
- 1,87 m

-Hauptbeschwerde

- Es ist offensichtlich, dass ich ein Problem habe.
- Seit heute Morgen habe ich Brustschmerzen hier (zeigt mit dem Finger sein Herz) plötzlich wie ein Messer und es zieht in den Hals, was habe ich?
  - Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen.
  - Momentan kann ich nicht sagen, welches Problem Sie haben. Ich muss Ihnen noch einige Fragen stellen.
  - Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um Sie.

Brustschmerzen/Engegefühl:

- Seit 1/2 Stunden/heute Morgen
- während der Arbeit im Büro
- Plötzlich
- In Ruhe
- Retrosternal
- Ausstrahlung: li. Arm
- Am Anfang stechend/brennend/ziehend/dumpf dann drückend
- Ähnliche Beschwerden: letzten Jahr, 2-3 Mal (im Sommer, vor 2 Monaten), nur bei Belastung (Treppensteigen), 30 Minuten Wie lange hat das gedauert?
- Am Anfang 5-6/10, jetzt 3-4/10
- Regressiven: Die S. haben sich verbessert

B-Symptome:

- Kaltschweißigkeit
- Nausea: Übelkeit
- Vertigo (Schwindel)/Schwarz vor Augen. Haben Sie das Bewusstsein verloren?
  - Welche Art von Schwindel? Ist es so, wie auf einem Boot bei starkem Seegang (Schwankschwindel) oder eher wie im Karussell (Drehschwindel)?
- Fatigue: Müdigkeit
- Hyperhidrose: Schweißausbruch
- Palpitation: Herzklopfen
- Blässe: meine Töchter sagte mir, dass ich blass war

- Haben Sie geschwollene Beine/Wadenschmerzen bemerkt?
- Haben Sie Atemnot? Bekommen Sie Luftnot, wenn Sie flachliegen? Sind die S mit Atmung verbunden?
- Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?

- ich habe vor einem Jahr meinen Hausarzt besucht und er hat mir gesagt, dass ich auf meinen Cholesterinspiegel achten soll. Was machen Sie für mich?

* Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber Sie haben typischen Beschwerden einer Herzkrankheit (Herz. Deswegen muss ich sofort ein EKG und Ihnen etwas Blut abnehmen, um das zu bestätigen. Ich rufe jetzt an die Krankenschwester an. Und wir können das Gespräch weiterführen.

- Lassen Sie uns bitte das Gespräch zum Ende führen. Nein Doktor, warum nicht jetzt? Weil ich noch einige allgemeine Fragen an Sie habe, um eine Diagnose zu stellen.

-vegetative Symptomatik

- **Inappetenz +**: Ich habe derzeit keinen Hunger mehr
- **Gewichtszunahme + (3 kg in den 3 J)**: Ich habe in den letzten drei Jahren drei Kilo zugenommen
- **Insomnie**
  - Ich schlafe zurzeit nachts nicht gut, weil ich Angst habe, zu sterben.
    - Ich verstehe, aber man sollte versuchen, positiv zu denken.

Das ist völlig nachvollziehend

-Vorerkrankungen

- Was sind chronische Krankheiten?
- Ich habe keinen HA.
  - Es ist sehr wichtig, einen Hausarzt zu haben und ihn regelmäßig zu besuchen. Ich kann Ihnen gerne einen empfehlen, wenn Sie möchten.
- **chronischer Husten/ chronische Bronchitis** (aufgrund des Rauchens, mit Auswurf)
  - Ist er trocken oder mit Auswurf? Wie sieht den Auswurf aus?
- **Zytomegalievirus mit 25 LJ** (vergrößerte Lymphknoten) **Pfeiffer-Drüsenfieber (= Mononucleosis** ❑ EBV)?
- **Impfung: vollständig**

-Vor-OPs

- Was machen Sie für mich? / Welche Untersuchungen möchten Sie bei mir durchführen?
  - am Ende des Gesprächs werde ich Ihnen erklären, was wir als Nächstes tun werden.
- **Unterschenkel-OP li. wegen des Autounfalls ohne Komplikationen**

-Medikation

- ACC (Acetylcystein) **unklare Dosierung 1-0-0**: ich kann mich nicht mehr an die Dosis erinnern, die auf der Packung stand. Aber ich nehme nur eine Tablette. (Schleimlösendes Medikament)

-Allergien

keine

-Noxen

- **Nikotin: 20 Zig./d in den letzten 3 Jahren wegen Stress früher 10 Zig./d seit Langem (seit dem 18 LJ.)**
  - Ich habe versucht, aber das hat nicht geklappt.
    - Das wäre besser für Ihre Gesundheit. Keine Sorge! Der Sozialdienst unseres Krankenhauses kann Sie dabei unterstützen
- **C2: 1-2 Fl. Bier oder 2-3 Gl. Wein gel. Am WE**
- **Drogen: -**
  - Ohh nein und warum fragen Sie Herr Doctor danach?
    - Das ist nur um Sie so gut wie möglich zu behandeln. Drogen können Nebenwirkungen mit bestimmten Medikamenten haben

Weil Drogen Nebenwirkung Wechselwirkung mit bestimmten Medikament haben können und könnte vielleicht ein Medikament verordnen

- Als Drogen gab er Kaffee an (lustig).
  - Nein Kaffee ist keine Droge, ansonsten bin ich auch drogenabhängig

-Sozialanamnese

- Speditionskaufmann (Transport), manchmal stressig
  - Wissen Sie, was Speditionskaufmann bedeutet?
    - Können Sie mir sagen, worin Ihre Arbeit besteht? Die Planung und Organisation des Gütertransports
- verheiratet (auf dem Papier) / Leben getrennt voneinander seit 3 J.
- Lebe mit seiner Tochter, alleinerziehend
  - Meine Frau hat mich wegen eines anderen Mannes verlassen. Meine Frau hat mich heute mit meinem Freund betrogen. Sie wohnt jetzt mit einem anderen Mann in Thailand.
  - Meine Ex-Frau leidet an einer Wunde am Bein. Könnten Sie auch mein Bein untersuchen?
    - Das ist eine schwierige Situation. Ich möchte, dass wir uns jetzt auf Ihre Beschwerden konzentrieren, können wir unsere Gespräche weiterführen?

Ich verstehe, dass zum (wie sie schwierig sein. Bei der körperlichen Untersuchung würde ich Ihr Bein untersuchen. Machen Sie sich keine Sorge

- eine Tochter (11J. Pubertät)
  - Ich habe Probleme mit meiner Tochter, da sie sich in der Pubertät befindet.
  - Meine Tochter und meine Freundin streiten immer. Sie kann nicht in die Wohnung kommen.
    - ja manchmal ist die Pubertät nicht einfach, aber kommen wir auf Sie zurück.
- Sport: keine
  - Es ist für Ihre Gesundheit sehr wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Vielleicht können Sie versuchen, mindestens eine Stunde pro Tag zu Fuß zu gehen.

-Familienanamnese

- Vater: t mit 50/55 LJ. an MI, aHT, Glaukom (= grüner Star)
  - Ich habe Angst wie mein Vater HI zu haben? Werde ich davon sterben?
  - Ist grüner Star erblich? Was ist das? Was ist grüner Star? Kann meine Tochter daran leiden?
    - Es geht um erhöhte Augeninnendruck. Ob das erblich oder nicht, ist derzeit nicht nachgewiesen.
- Mutter: Rheumatoide Arthritis (medikamentös behandelt),
  - Sie hat BU, Kniegelenkentzündung
- Schwester: Adipositas, Depression, Varizen
  - Sie ist übergewichtig, BMI ist 35, Wie kann man sie behandeln?
  - Sie hat blaue Streifen unter die Haut? Was ist das? Sind Krampfadern behandelbar? Sollte meine Schwester operiert werden?
- Tochter (11 J.): Hühnerauge (Clavus)
  - Meine Tochter hat Hühnerauge, was soll ich machen? Zu welchem Arzt soll sie gehen? Sollte ich sie zum Augenarzt bringen?
    - Sie können ihren Hausarzt / Orthopädist bei diesen Beschwerden besuchen. Wir sind hier, um über Sie zu sprechen und darüber, was Sie heute ins Krankenhaus bringt.

⇒ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht auf **Herzkrankheit (Herzkranzgefäßverengung)**.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.

Ich werde Ihnen zuerst Blut abnehmen, damit wir die Ergebnisse so schnell wie möglich erhalten. Dann werde ich Ihren Körper untersuchen. Danach werde ich ein EKG machen. Wissen Sie, was das ist?

EKG: Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

Während der Untersuchung Sie sollen ganz ruhig bleiben.

-Fragen

Ist es gefährlich?
Warum soll ich hierbleiben?
Kann ich gehen, weil ich meine Töchter von der Schule abholen muss?
Wo wird meine Tochter bleiben?

- Vielleicht können Sie jemanden anrufen, der sich um Ihre Tochter kümmert. Sie werden eine Weile hier bleiben müssen, wenn Sie sich besser fühlen wollen. Aber wir werden uns sehr gut um Sie kümmern, machen Sie sich keine Sorgen.
- Können Sie sie auch anrufen, damit sie mit Ihnen hierher kommt. Sie hat das Recht, in Ihrem Zimmer zu bleiben

Soll ich im KH bleiben? Was habe ich?
Habe ich Risikofaktoren für einen Herzinfarkt? Wenn ja, welche?

- Sie rauchen, haben einen hohen Cholesterinspiegel und treiben keinen Sport, so dass Sie alle Risiken für eine Herzerkrankung haben.

Sind Herzinfarkte erblich?
Was ist mit mir passiert, wieso sind diesen Symptomen aufgetreten?
Was werden sie mit mir machen?
Was ist EKG, ist es schmerzhaft?
Werden Sie mir mit Metallplättchen in den Körper stechen?

- Nicht unbedingt. Wir müssen erst weitere Untersuchungen durchführen und dann erkläre ich Ihnen die Behandlungsmöglichkeiten.

Was ist MI?

- Ein Herzinfarkt ist eine Erkrankung, bei der die Herzkranzgefäße verstopft sind. Dadurch erhält der Herzmuskel nicht mehr genug Blut, um richtig zu funktionieren. Die Gefäße müssen so schnell wie möglich wieder frei gemacht werden.

Muss ich gespritzt werden? Wir haben kleine Nadeln
Müssen Sie Mittel ins Blut spritzen? Kontrastmittel
Komme ich in die Röhre?
Ich will jetzt rauchen.

- nein Sie dürfen jetzt nicht rauchen. Wir müssen weitere Untersuchungen durchführen und Sie so schnell wie möglich behandeln.

Machen Sie für mich Magenspiegelung?
Soll ich in Rohr sitzen? Wir machen Schritt zum Schritt
Warum machen Sie einen Herzultraschall? Bin ich schwanger?

- ein Ultraschall ist eine Routineuntersuchung, um die inneren Organe zu untersuchen, nicht nur bei Schwangeren

Arzt-Arzt-Gespräch

Ich möchte euch einen sehr interessanten Fall vorstellen, den ich heute während meiner Schicht hatte.

Es geht um Herm **Florian Willms, 42** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt seine aktuellen Symptome wie folgt: seit heute Morgen drückende persistierende retrosternale Schmerzen. 4 von 10 auf einer Schmerzskala. Ausstrahlung in li.Arm. Seit letzten Jahr ähnliche progrediente Beschwerden nur bei Belastung. Als Begleitsymptome, klagt er über Angina Pectoris, Nausea, Dyspnoe, Palpitationen, Kaltschweiße, Fatigue, Vertigo.

Er berichtet auch Insomnie wegen Todesangst und hat in der letzten 3 Jahren 3 Kilos zugenommen. Restliche vegetative Anamnese war unauffällig.

Er hat seit 10 Jahren chronische Husten und nimmt regelmäßig ACC dagegen ein. Ich würde dies während der körperlichen Untersuchung fragen.

Der Patient raucht 13 p.y. (10 Zig/d. während 20J., 20 Zig./d seit 3 J.). Er arbeitet als Lehrer. Deshalb ist er sehr gestresst (körperliche / psychische Belastung) und ängstlich.

In der Familienanamnese gibt es: MI

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf akutes Koronarsyndrom. Als Differentialdiagnose kann ich Lungenembolie, Pneumothorax, Refluxkrankheit (GERD), Tietze-Syndrom und Aortendissektion aufzählen.

Ich möchte jetzt eine körperliche Untersuchung durchführen, ein EKG, eine Laboruntersuchung mit großem Blutbild, den Entzündungsparametern (CRP, BSG) / Gerinnungsparametern (einschließlich D-Dimere) / E-lyten (Na, K, Ca), Leber-, Nierenwerte, TSH, Herzmuskelenzyme (Troponine I, CKMB), eine transthorakale Echokardiographie und eine kardiologische Konsil (Beratung).

Ich werde Ihn stationäre aufnahmen. Als initiale / symptomatische Behandlung, empfehle ich:

- Vitalparameter-Monitorings und 2 großlumige intravenöse Zugänge
- Dann den MONA-BH-Schema: Morphin 2,5-5 mg i.v. langsam (Antiemetika b.B.), Sauerstoff aus der Maske, ASS 75-250 mg i.v.,
- Danach Heparin 5000 IU i.v. / Ggf. Clopidogrel 600 mg p.o., Atorvastatin 40-80 mg p.o.

Dann, wenn die Herzenzyme und das EKG positiv auf einen Myokardinfarkt hinweisen, schlage ich eine kausale Behandlung vor, eine perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA).

Fragen

Fragen nach Gewicht und Größe: für BMI, Dosierung
Geburtsname: Familienname einer Person vor der Hochzeit
Was ist Herzrasen? Herzfrequenz auf über 100 Schläge pro Minute.
Kaltschweißigkeit? Wo ist kalt? Kaltschweißigkeit: starkes Schwitzen bei kalter Haut, ausgelöst wird durch Aktivierung des sympathischen Nervensystems.

Erkrankungen des CMVs: sehr selten bei Erwachsenen
- Grippeartige Beschwerden (häufig)

Immunschwäche, Schwangerschaft, Neugeborenen

- Pneumonie, Hepatitis (selten)
- Enzephalitis, Kolitis, Ösophagitis, Retinitis (bei geschwächtem Immunsystem)
- Hepatosplenomegalie, LAP

Welchen Organen kann das Rauchen schaden?
- Arteriosklerose → pAVK, MI, Apoplex/TIA, Mesenterialinfarkt
- erektile Dysfunktion
- COPD
- Bronchialkarzinom
- Gingivitis und Parodontitis

Was passiert mit Blutgefäßen wegen Rauchen? Arteriosklerose (Gefäßverkalkung, Ablagerung), sie reißen leichter

Die Pubertät ist die Entwicklungsphase, in der der Körper eines Kindes unter dem Einfluss von Hormonen geschlechtsreif wird.

Was ist Pubertät? Die Pubertät ist der zu sexueller und körperlicher Reife führende Teil der menschlichen Entwicklung, in dessen Verlauf ein Kind zum Erwachsenen wird.

einschließlich

Unterteilung von ACS: STEMI, NSTEMI, instabile Angina
Risikofaktoren des Pat.
Risikofaktoren für ACS: Rauchen, aHT, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes (+ falsche Ernährung, erhöhter Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, Stress)
Myokardinfarkt Kriterien:
- erhöhte herzmuskelspezifischen Enzymen (Troponin T, Troponin I und CK-MB)
- EKG: ST-Hebung

Woraus stimmt Angina pectoris? auf der Stenosierung (Verengung) einer Koronararterie
Komplikationen von MI: HRST wie VHF und Herzkammerflimmern

Warum Perikarditis, Symptome? Retrosternalen und atemabhängige Schmerzen mit begleitendem Fieber
Warum LAE? Weil sie zu den Notfällen gehört, die bei akuten Thoraxschmerzen in Betracht gezogen werden müssen (Tachypnoe, Tachykardie, Zyanose, Husten, Schwindel, Schweißausbruch).
LE: Lungenembolie, Lupus erythematodes (= Schmetterlingsflechte), Laryngektomie

Was sind vitale Parameter:
- Herzfrequenz = Puls
- Atemfrequenz
- Blutdruck
- Körpertemperatur
- Sauerstoffsättigung (sO_2)
- Blutzucker (= Glukose)
- Rekapillarisierungszeit (= Fingernagelprobe)

Fragen über CK, Trop I und T: wichtige Komponente für die Muskelkontraktion:
- Troponin I: weist eine starke Affinität für Aktin auf (< 10 µg /l)
- Troponin T: bindung an Tropomyosin verantwortlich (0 - 0.04 ng/ml)

Gesamt Chol-Werte:
- Gesamtcholesterin: weniger als 2 g/l oder 5 mmol/l
- LDL-Cholesterin: weniger als 1,6 g/l oder 2,6 mmol/l
- HDL-Cholesterin: über 0,4 g/l oder 1,3 mmol/l bei Frauen und über 1 mmol/l bei Männern
- Triglyceride: weniger als 1,5 g/l

Häufigste Ursache von Perikarditis: viral (Coxsackies, Influenza, Adenoviren)
- **Virale Infektionen: Coxsackie-Virus, Influenzavirus, Adenovirus**
- **Bakterielle Infektionen: *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylokokken*, *Haemophilus*, Tuberkelbakterien**

- Pilzinfektionen: Candida, Aspergillus flavus
- Parasitäre Infektionen
- Systemische Erkrankungen: Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen, Rheumatoide Arthritis, Sarkoidose, Endokrinologische Erkrankungen
- Im Rahmen anderer Organerkrankungen: Myokarditis, Endokarditis, Pneumonie, terminale Niereninsuffizienz mit Urämie
- Paraneoplastisch: Mammakarzinom, Bronchialkarzinom, Lymphome
- Posttraumatisch
- idiopathisch

Warum sterbt man an MI: Komplikationen

Welche Laborwerte sind vor der Angiografie wichtig? Nierenwerte, Gerinnungsparameter, TSH, Thrombozyten

Wie kann man durch Echo HI erkennen? Wandebewegungsstörung, apikale Akinesie (ein Hinweis auf MI)

Der Patient sagt, dass ich gehen sollte, um mich um meine Tochter zu kümmern: Was machen Sie? Ich rufe
den Sozialdienst an. Er muss den gegen ärztlichen Rat unterschreiben und ich muss einen vorzeitigen Entlassungsbrief schreiben.

Unterschied zwischen subduralem Hämatom und SAB:

- **SDH**: Einblutung in den Subduralraum, CT: konkav/sichelförmig verlaufende
- **SAB**: arterielle Blutung in den Subarachnoidalraum, SHT und Ruptur eines Aneurysmas, hyperdenses Blut in basalen Zisternen und Sulci

Neurologische Untersuchung:

- Hirnnervfunktion
- Reflexprüfung
- Sensibilitätsprüfung
- Muskelkraft und -tonus
- Gang und Gleichgewicht

Was ist der Unterschied zwischen Köln und Düsseldorf

- Köln 1. größte Stadt NRW und 4. größte Stadt BDR
  - Kölsch
- Düsseldorf Hauptstadt und sie streiten immer deswegen **dann bzgl. Getränke?**
  - altes Bier

Intrathekal: innerhalb der Dura mater, d.h. in den Liquorraum

- Wird meist in Zusammenhang mit Injektionen verwendet, die direkt in den Liquorraum appliziert werden – zB. im Rahmen einer Chemotherapie oder bei bestimmten Anästhesieverfahren.

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ in

Franz Balter
39 J. 02.02.1983
187 cm m 94,5 kg

Datum

01.01.2026

(nur Stichpunkte) aktuelle Beschwerden

- Brustschmerzen, seit einer Stunde, retrosternal
- Ausstrahlung in den linken Arm
- in der Ruhe plötzlich aufgetreten
- brennend, drückend, dumpf
- anfangs 5-6/10 auf der Schmerzskala, aktuell jetzt 3-4/10
- rezidivierend seit einem Jahr, 2-3 Mal, Dauer: 10-30 Minuten
nur bei Belastung
- Begleitsymptome
  - Dyspnoe
  - Kaltschweiß
  - Vertigo
  - Müdigkeit
  - Nausea
  - Todesangst
  - Blasse ~~X~~ Aussicht Hautblässe

Vegetativanamnese
- Nykturie seit 1 Jahr
- Inappetenz seit 1 Jahr
- Gewichtsabnahme von 3 kg in 1 Jahr

Vorerkrankungen

- ~~2x~~ 1. CMV Infektion mit 25 LJ.
(mit Medikamenten behandelt wurde)
- aHT seit 10 Jahren (letzte Messung: 130/80)
- chronischer Husten seit 20 Jahren (v.a. Raucher Husten)

OP

- ~~2x~~ 1. Platten-Osteosynthese mit 21 Jahre LJ. wegen Autounfall
- ~~2x~~ 1. Plattenextraktion mit 22 Jahre LJ. dazu ~~Ant~~ Unterschenkelfraktur rechts

Medikamente

- ACC unklare Dosis (1-0-0)

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

unauffällig

Genussmittel

Nikotin: letzte 3 Jahren 20 Zigaretten täglich
früher 18 Jahre lang 10 Zigaretten täglich) ca 12 py

Alkohol: 1-2 Flasche Bier oder Rotwein am Wochenende

Drogen: unauffällig

Sozialanamnese

- Speditionkaufmann
- Stress bei der Arbeit und im privaten Leben
- verheiratet (lebt getrennt)
- eine Partnerin
- eine Tochter (Pubertät)

Familienanamnese

Vater → an MI mit 55 Jahren gestorben, aHT

Mutter → Rheumatoide Arthritis

Schwester → Depression, Adipositas, Varizen

Tochter → Clonus, Hordeolum (Gerstenkorn)

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

akutes Koronarsyndrom (ACS)

Differentialdiagnose

- Lungenarterialembolie
- Aortondissektion
- GERD

weiteres Procedere

- KU
- Vital Parameter, EKG Herzmuskelenzyme
- Labor: gr. BB, CRP, Herzenzyme (Troponin T, I, CKMB), D-Dimer, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Lipidprofile, BZ,
- Echokardiographie
- Röntgen-Thorax
- ~~ggf. CT Thorax~~

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Monitoring, Bettruhe
- MONA-BH → ggf Morphin 3-5 mg i.v
  ggf Sauerstoff SpO2 < 92%
  Nitroglycerin sublingual oder als Spray bei kein Hypotonie
  Aspirin 300 mg i.v
  Heparin 5000 IE i.v
- ein Konsil in Kardiologie
- ggf PCI oder BY-PASS OP
- Nikotinkarenz, Lebensstilveränderungen (gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, Stressbewältigung)
- ~~Sekundärprophylaxe:~~ unterstützende Medikamente: Beta Blocker, ACE-Hemmer, Statine, ASS und Clopidogrel

Eine CMV-Infektion wird durch ~~CMV~~ das Cytomegalovirus verursacht. Bei gesunden Menschen verläuft sie meist mild oder asymptomatisch, ähnlich wie eine Mononukleose. Gefährlich kann sie jedoch bei immunsupprimierten Patienten, Schwangeren und Neugeborenen werden und dort Organentzündungen wie Retinitis, Hepatitis, Pneumonie oder Kolitis verursachen.

Die Diagnose erfolgt über PCR oder Serologie. In schweren Fällen wird mit Ganciclovir oder Valganciclovir behandelt

Was
Wer
Wann.
Wie → plötzlich/langsam.
Notfall verdacht varsa → kes.
Luftnot, Engegefühl,
Kaltschweiß, Kehlkopfstörung ...

Danisch

ACC → Acetylcystein
schleimlösendes Medikament

Die Herzkranzgefäße versorgen den Herzmuskel mit Blut und Sauerstoff
Bei einer Verengung kommt es zu einer Minderdurchblutung also Angina pectoris oder Herzinfarkt

(Right Coronary Artery)
Arteria coronaria dextra → ACD → RCA → Sog. Ramus interventricularis posterior
(Left Main Coronary Artery)
Arteria coronaria sinistra → ACS → LMCA → Ramus interventricularis anterior

Sul. anterior interventricularis → Left Anterior Descending → LAD
Ramus interventricularis anterior → RIVA
↓
Sept. ventriculi anterior

Sul. circumflexus dex. → Left circumflex → LCX
Ramus circumflexus → RCX
↓
Sept. ventriculi posterior

Sog. posterior interventricularis → Posterior Descending Artery → PDA
Ramus interventricularis posterior → RIVP

Fettgedruckt bedeutet, dass das Wort schwarzeund diese geschrieben wird. Pathologische Werte oder auffällige Befunde werden

LDH ist ein Marker für Zellschädigung und Gewebsnekrose, während Laktat auf anaeroben Stoffwechsel und Gewebehypoxie hinweist.